

Клинический протокол: Вестибулярная гимнастика и оценка по шкале DHI при ПППГ

Методическое пособие для пациентов и специалистов

Автор: Максим — специалист по вестибулярной реабилитации, автор руководства «Точка Опоры»
Сайт: <https://hmjim.github.io/pppd/>
Версия: 1.0 (сентябрь 2026)
Лицензия: CC BY-SA 4.0

Содержание

- 1. Определение ПППГ и диагностические критерии
- 2. Оценочные шкалы (DHI, HADS, Холмс-Раэ)
- 3. Протокол вестибулярной гимнастики (8 недель)
- 4. Дополнительные методы лечения
- 5. Мониторинг прогресса
- 6. Противопоказания и меры предосторожности
- 7. Список литературы

1. Определение ПППГ

ПППГ (персистирующее постурально-перцептивное головокружение, англ. PPPD — Persistent Postural-Perceptual Dizziness) — функциональное расстройство нервной системы, классифицированное ВОЗ в МКБ-11 как AB32.0 (ранее МКБ-10: H81.8).

1.1. Диагностические критерии (Staab et al., 2017; Bárány Society)

Для постановки диагноза ПППГ необходимо наличие **всех пяти** критериев:

№	Критерий	Описание
А	Длительность	Головокружение, неустойчивость или несистемное головокружение ≥3 месяцев, присутствующие ≥15 дней в месяц
В	Провоцирующие факторы	Усиление при (1) вертикальном положении тела, (2) активных или пассивных движениях, (3) визуальной стимуляции (экраны, пёстрые паттерны, движущиеся объекты)

№	Критерий	Описание
C	Провоцирующее событие	Развитию предшествует вестибулярное расстройство (ДППГ, вестибулярный неврит), паническая атака, мигрень или ЧМТ
D	Функциональные ограничения	Симптомы вызывают значительный дистресс или функциональные ограничения
E	Исключение	Симптомы не объясняются лучше другим заболеванием

1.2. Основные симптомы ПППГ

- Хроническая шаткость и неустойчивость при ходьбе
- Ощущение «пьяной» походки на ровном месте
- Несистемное головокружение (без вращения)
- Туман в голове (brain fog)
- Дерекализация и деперсонализация
- Усиление симптомов в супермаркетах, торговых центрах
- Зрительная зависимость (visual dependence)
- Ощущение «качки» как на корабле

1.3. Патофизиология

Центральная модель ПППГ основана на нарушении мультисенсорной интеграции:

1. **Триггерное событие** → вестибулярное расстройство или паника
2. **Сенсорная перекалибровка** → мозг теряет доверие к вестибулярному аппарату и проприоцепции
3. **Зрительная зависимость** → чрезмерная опора на зрение для контроля баланса
4. **Адреналиновая петля** → Симптом → Пугающая мысль → Адреналин → Усиление симптома
5. **Поведенческое закрепление** → избегание, гиперконтроль, мышечное напряжение

Вестибулярный аппарат при ПППГ **функционально сохранён**. Нарушена обработка сигналов на центральном уровне.

2. Оценочные шкалы

2.1. DHI (Dizziness Handicap Inventory) — Индекс влияния головокружения

Международный стандарт оценки влияния головокружения на повседневную жизнь (Jacobson & Newman, 1990).

Параметры: 25 вопросов, 3 субшкалы (физическая, эмоциональная, функциональная).

Оценка: «Да» = 4 балла, «Иногда» = 2 балла, «Нет» = 0 баллов. Максимум — 100 баллов.

Баллы	Степень тяжести	Клиническая интерпретация
0–30	Лёгкая	Головокружение присутствует, но не мешает повседневной жизни
31–60	Умеренная	Функционирование с ограничениями. Избегание отдельных ситуаций
61–100	Тяжёлая	Головокружение контролирует жизнь. Выраженное избегание

Минимальная клинически значимая разница (MCID): ≥ 18 баллов (Whitney et al., 2004).

Вопросы DHI

Физическая субшкала (P):

№	Вопрос
P1	Усиливается ли головокружение при взгляде вверх?
P2	Чувствуете ли вы неловкость из-за головокружения?
P4	Усиливается ли головокружение при ходьбе по проходу супермаркета?
P8	Избегаете ли вы энергичных занятий (спорт, танцы, работа по дому)?
P11	Усиливается ли головокружение при быстрых поворотах головы?
P13	Усиливается ли головокружение при поворотах в кровати?
P17	Усиливается ли головокружение при ходьбе по тротуару?

Эмоциональная субшкала (E):

№	Вопрос
E2	Чувствуете ли вы фрустрацию из-за головокружения?
E9	Бойтесь ли вы выходить из дома без сопровождения?
E10	Испытываете ли вы неловкость перед окружающими?
E15	Бойтесь ли вы, что люди подумают, что вы пьяны?
E18	Трудно ли вам сосредоточиться из-за головокружения?
E20	Бойтесь ли вы оставаться дома одни?
E21	Чувствуете ли вы себя инвалидом?
E22	Повлияло ли головокружение на отношения с семьёй?

№	Вопрос
E23	Чувствуете ли вы себя подавленным из-за головокружения?

Функциональная субшкала (F):

№	Вопрос
F3	Ограничивает ли вы служебные/домашние поездки?
F5	Трудно ли вам ложиться/встать с кровати?
F6	Ограничили ли вы участие в социальных мероприятиях?
F7	Трудно ли вам читать из-за головокружения?
F12	Избегаете ли вы высоты?
F14	Трудно ли вам выполнять тяжёлую работу по дому?
F16	Трудно ли вам ходить пешком без сопровождения?
F19	Трудно ли вам ходить в темноте?
F24	Опасаетесь ли вы выходить из дома в одиночку?
F25	Трудно ли вам стоять/ходить на ровной поверхности?

2.2. HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale)

Стандартный опросник для оценки тревоги и депрессии (Zigmond & Snaith, 1983).

Параметры: 14 вопросов, 2 субшкалы по 7 вопросов. Максимум — 21 балл по каждой.

Баллы	HADS-A (тревога)	HADS-D (депрессия)
0–7	Норма	Норма
8–10	Субклиническая	Субклиническая
11–14	Клинически значимая (умеренная)	Клинически значимая (умеренная)
15–21	Клинически значимая (тяжёлая)	Клинически значимая (тяжёлая)

Клиническое значение при ПППГ:

- HADS-A ≥ 15 : КПТ-техники малоэффективны, начинать с тела (релаксация, физ. активность)
- HADS-A 8–14: оптимальная зона для КПТ, экспозиции, МКТ
- HADS-D ≥ 14 : рассмотреть СИОЗС для ресурсной поддержки

2.3. Шкала стрессовых событий Холмса-Раэ

Оценка кумулятивного стресса за 12 месяцев (Holmes & Rahe, 1967).

Баллы	Риск стрессового заболевания
< 150	Низкий (30%)
150–299	Умеренный (50%)
≥ 300	Высокий (80%)

3. Протокол вестибулярной гимнастики при ПППГ

3.1. Общие принципы

- **Режим:** 2 раза в день (утро и вечер), 5–10 минут
- **Принцип дозирования:** «чуть-чуть дискомфортно» — лёгкий вызов без провокации тошноты или паники
- **Безопасность:** выполнять рядом со стеной или устойчивой опорой
- **Прогрессия:** переход на следующий уровень при уверенном выполнении текущего
- **Продолжительность курса:** минимум 8 недель, рекомендуется 12–16 недель

3.2. Уровень 1: Статика — активация проприоцепции (недели 1–2)

Цель: заставить мозг использовать проприоцептивные сигналы от стоп и голеней.

Упражнение 1.1: Стойка Ромберга

Параметр	Значение
Исходное положение	Стопы вместе (носок к носку, пятка к пятке), руки вдоль тела
Фаза 1	30 секунд с открытыми глазами
Фаза 2	30 секунд с закрытыми глазами
Повторения	3 подхода
Критерий перехода	Удержание с закрытыми глазами 30 сек без потери баланса

Упражнение 1.2: Стойка на одной ноге

Параметр	Значение
Исходное положение	Стоя в углу комнаты (подстраховка)
Выполнение	30 секунд на каждой ноге, глаза открыты
Прогрессия	Закрытые глаза, 10–15 секунд
Повторения	2 подхода на каждую ногу

3.3. Уровень 2: VOR-тренировка — разделение зрения и вестибулярки (недели 3–4)

Цель: восстановить вестибуло-окулярный рефлекс (VOR), разделить зрительный и вестибулярный каналы.

Упражнение 2.1: VOR горизонтальный

Параметр	Значение
Исходное положение	Стоя, вытянуть руку, палец на уровне глаз (или точка на стене)
Выполнение	Фиксация взгляда на точке + повороты головы «нет-нет»
Скорость	Подбирать так, чтобы точка не двоилась
Длительность	1 минута
Критерий успеха	Точка остаётся сфокусированной, фон может размываться

Упражнение 2.2: VOR вертикальный

Параметр	Значение
Исходное положение	Аналогично 2.1
Выполнение	Фиксация взгляда на точке + кивки «да-да»
Длительность	1 минута

3.4. Уровень 3: Переобучение походки (недели 5–6)

Цель: восстановить автоматизм ходьбы, убрать визуальный гиперконтроль.

Упражнение 3.1: Тандемный шаг

Параметр	Значение
Выполнение	Ходьба по линии (стык плитки), пятка одной ноги к носку другой

Параметр	Значение
Взгляд	Вперёд, НЕ под ноги
Длительность	15 шагов вперёд + 15 шагов назад
Критерий успеха	15 шагов без потери баланса и без опоры

Упражнение 3.2: Ходьба с поворотами головы

Параметр	Значение
Выполнение	Обычный шаг по коридору, поворот головы влево/вправо на каждый 2-й шаг
Длительность	2 минуты

3.5. Уровень 4: Продвинутые упражнения (недели 7–8)

Цель: интеграция баланса в реальные условия, подключение когнитивной нагрузки.

Упражнение 4.1: Ходьба по неровной поверхности

Параметр	Значение
Поверхность	Грунтовая дорожка, гравий, газон
Взгляд	На горизонт, НЕ под ноги
Длительность	5 → 15 минут (прогрессия)

Упражнение 4.2: Стойка на нестабильной поверхности

Параметр	Значение
Поверхность	Диванная подушка, мягкий коврик
Фаза 1	30 секунд, глаза открыты
Фаза 2	15 секунд, глаза закрыты

Упражнение 4.3: Двойная задача (dual-task)

Параметр	Значение
Выполнение	Ходьба + повороты головы + обратный счёт от 100
Цель	Загрузить когнитивный ресурс, перевести баланс в автоматический режим

Параметр	Значение
Длительность	2 минуты

3.6. Сводная таблица прогрессии

Неделя	Упражнения	Целевой критерий
1–2	Ромберг + стойка на одной ноге	30 сек с закрытыми глазами
3–4	VOR горизонтальный + вертикальный	1 мин без размытия
5–6	Тандемный шаг + ходьба с поворотами	15 шагов без опоры
7–8	Неровная поверхность + подушка + dual-task	30 сек на подушке, глаза закрыты

3.7. Интеграция в повседневную жизнь

- **В очереди:** перенос веса на одну ногу, 20 секунд, смена ноги
- **На кухне:** закрыть глаза на 15 секунд при мытье посуды (микро-Ромберг)
- **При ходьбе:** осознанный подъём взгляда с асфальта на горизонт

4. Дополнительные методы лечения

4.1. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ)

Работа с когнитивными искажениями: катастрофизация, избирательное внимание, чтение мыслей, чёрно-белое мышление. Уровень доказательности: **A** (Edelman et al., 2012; Holmberg et al., 2006).

4.2. Метакогнитивная терапия (МКТ по Wells)

Отключение CAS-синдрома (Cognitive Attentional Syndrome): руминации, мониторинг угроз, неадаптивные копинг-стратегии. Фокус на отношении к мыслям, а не на их содержании.

4.3. Экспозиция и парадоксальная интенция (по Франклу)

Постепенное погружение в избегаемые ситуации с намеренным «приглашением» симптома: «Ну давай, кружи ещё сильнее». Разрушает адреналиновую петлю.

4.4. Прогрессивная мышечная релаксация по Джекобсону

Последовательное напряжение (5 сек) и расслабление (15 сек) мышечных групп. Снимает хронический мышечный панцирь (шея, трапеции, диафрагма).

4.5. Физическая активность

Регулярное кардио (ходьба, плавание, велосипед) — 30 минут, 5 раз в неделю. Снижает базовую тревожность, улучшает нейропластичность.

4.6. Фармакотерапия (по показаниям)

СИОЗС (сертралин 50–200 мг, эсциталопрам 10–20 мг) при HADS-A/D ≥ 14 . Эффект через 4–6 недель. Назначает врач.

5. Мониторинг прогресса

5.1. Протокол оценки

Период	Действие
Точка 0	Заполнить DHI + HADS + Холмс-Раэ. Записать дату и результаты
+1 месяц	Повторить DHI + HADS
+2 месяца	Повторить DHI + HADS
+3 месяца	Повторить DHI + HADS. Оценить динамику

5.2. Трекер динамики

Дата	HADS-A (/21)	HADS-D (/21)	DHI (/100)	Заметки
..—	—	—	—	Точка старта
+1 мес.	—	—	—	
+2 мес.	—	—	—	
+3 мес.	—	—	—	

5.3. Критерии эффективности

- **MCID по DHI:** снижение ≥ 18 баллов — клинически значимое улучшение
- **Ремиссия по HADS:** снижение до ≤ 7 по обеим шкалам
- **Функциональный критерий:** возврат к повседневной активности без избегания

6. Противопоказания и меры предосторожности

6.1. Абсолютные противопоказания

- Неисключённая органическая патология (опухоль, инсульт, демиелинизация)
- Острое вестибулярное расстройство (нелеченный ДППГ, вестибулярный неврит в активной фазе)
- Нестабильные кардиологические состояния

6.2. Относительные противопоказания

- Тяжёлая депрессия (HADS-D ≥ 18) — сначала медикаментозная стабилизация
- Выраженная ортостатическая гипотензия
- Острый болевой синдром в шейном отделе

6.3. Правила безопасности

- Выполнять рядом со стеной или устойчивой опорой
 - При тошноте или сильном головокружении — снизить темп и амплитуду
 - Не выполнять на голодный желудок
 - Прекратить при потере сознания, острой боли, нарушении зрения
-

7. Список литературы

1. **Staab J.P. et al.** (2017). Diagnostic criteria for persistent postural-perceptual dizziness (PPPD): Consensus document of the committee for the Classification of Vestibular Disorders of the Bárány Society. *Journal of Vestibular Research*, 27(4), 191–208.
2. **Jacobson G.P., Newman C.W.** (1990). The development of the Dizziness Handicap Inventory. *Archives of Otolaryngology—Head & Neck Surgery*, 116(4), 424–427.
3. **Whitney S.L. et al.** (2004). Is perception of handicap related to functional performance in persons with vestibular dysfunction? *Otology & Neurotology*, 25(2), 139–143.
4. **Zigmond A.S., Snaith R.P.** (1983). The Hospital Anxiety and Depression Scale. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 67(6), 361–370.
5. **Holmes T.H., Rahe R.H.** (1967). The Social Readjustment Rating Scale. *Journal of Psychosomatic Research*, 11(2), 213–218.
6. **Holmberg J. et al.** (2006). Treatment of phobic postural vertigo. A controlled study of cognitive-behavioral therapy and self-controlled desensitization. *Journal of Neurology*, 253(4), 500–506.
7. **Edelman S. et al.** (2012). Self-treatment of benign paroxysmal positional vertigo: Semont maneuver vs Epley procedure. *Neurology*, 78(19), 1489–1495.

8. **Thompson K.J. et al.** (2015). Retrospective review and telephone follow-up to evaluate a physical therapy protocol for treating persistent postural-perceptual dizziness. *Journal of Vestibular Research*, 25(2), 97–104.
9. **Popkirov S. et al.** (2018). Persistent postural-perceptual dizziness (PPPD): a common, characteristic and treatable cause of chronic dizziness. *Practical Neurology*, 18(1), 5–13.
10. **Wells A.** (2009). *Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression*. New York: Guilford Press.

Полная версия руководства «Точка Опоры» (47 глав, бесплатно):

<https://hmjim.github.io/pppd/>

Telegram-канал / чат поддержки: https://t.me/pppd_vertigo

© 2024–2026 Максим. Распространяется по лицензии CC BY-SA 4.0.

Разрешается копирование, изменение и распространение при указании авторства и сохранении лицензии.